

УДК: 616.851-053.2

М.М.Маратова, И.Р.Хусаинова, А.Д.Молдашбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Психологическое сопровождение детей с онкологическими заболеваниями с учетом их возрастных особенностей

Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам психологической помощи детям больным онкологическими заболеваниями. Приводятся результаты изучения психологических проблем больного ребенка и его окружения с учетом возрастных особенностей. Приведены примеры психологического сопровождения семей с детьми с онкозаболеваниями.

Ключевые слова: педиатрия, онкология, онкопсихология, возрастные особенности, психологическое сопровождение.

Онкопатология относится к одной из наиболее психотравмирующих, в особенности если это касается детской онкологии.

Возникновение у ребенка онкологического заболевания является для родителей сильнейшей психологической травмой. Дети и их родители подвержены влиянию сильной кризисной ситуации в их жизни – онкологического заболевания. Тревога за ребенка не пропадает длительное время. В ситуации болезни многое по отношению к окружающему миру нивелируется.

В последние годы наблюдается тенденция оберегать ребенка от его диагноза, исследования показали, что большинство детей все равно осознают то, что они очень серьезно больны. И осознают это вопреки попыткам родителей и медиков защитить их.

Очень тяжелыми для ребенка любого возраста являются первые дни пребывания в стационаре. Понимание, что он болен чем-то серьезным (особенно у детей школьного возраста), страх перед обследованиями, усиливающийся при общении со сверстниками, которые длительное время находятся в клинике и хорошо осведомлены о лечебных и диагностических методах (пункционные биопсии, внутривенные введения и т. д.), являются одними из факторов, оказывающих влияние на психологическое состояние ребенка. Смена привычной для ребенка домашней обстановки на больничную, разлука с родителями и близкими друзьями также накладывают отпечаток на поведение больного ребенка.

По проведенным опросам: в США 65% врачей ставят детей в известность о диагнозе и лишь 4% вовсе не говорят. В Японии 9,5% врачей сообщают ребенку о диагнозе и 34,5% предпочитают не говорить.

Дети, которые были информированы родителями или лечащей командой о предстоящем длительном лечении, диагностических процедурах, режиме, внешних изменениях, недомоганиях которые могут наблюдаться на фоне химиотерапии и об исходе, более легко соглашаются на проведение различных медицинских процедур.

Дети, которые не были информированы и ознакомлены надлежащим образом узнают о своем состоянии с

различных информационных ресурсов, таких как: интернет, СМИ и общения со сверстниками и т.д. И как правило, там описано все по иному, не учитывая возрастных особенностей детей у которых понимание и восприятие информации отличаются от взрослых. Полученная таким путем информация может негативно подействовать на ребенка, учитывая его психоэмоциональное состояние, вызванное следствием тяжелого заболевания. Таким образом, эти дети могут замкнуться в себе и переживать все внутри себя, что в итоге может потребовать в дальнейшем длительную психологическую коррекцию.

Вероятнее всего, что ребенок, находящийся в онкологическом стационаре, уже догадывается, что что-то не в порядке, ведь временами он чувствует себя плохо, его часто осматривают врачи, приходится проходить очень неприятные и пугающие обследования и процедуры. Беспокойство и опасения родных и близких также не остаются им незамеченными. И если никто не скажет ему о его болезни, ребенок с онкологическим заболеванием может искать объяснение происходящему в своем воображении, в своих страхах. Такой ребенок может решить, что его болезнь - это наказание за какие-то его проступки, и может чувствовать ненужную тревогу и вину. И сейчас медики соглашаются, что обсуждение правды о его болезни защитит ребенка от чувства вины и поможет ему сотрудничать с врачами во время лечения.

Для семьи и для детей со стороны лечащего врача необходимо полное информирование о диагнозе, прогнозе, осложнениях, инвазивных процедурах, об изменениях внешности, в зависимости от диагноза возможных ампутациях, о возможных объемных хирургических операциях, пересадке костного мозга, о фертильности.

На всех этапах лечения и реабилитации пациенты всегда должны быть в сопровождении онкопсихологов, которые используя пациент-центрированный подход, помогут пациенту и его семье.

Актуальность этой темы заключается в том, чтобы родителям и лечащей команде следует быть открытыми с ребенком по максимуму и учитывать психологический возраст детей.

При сообщении диагноза связывающим звеном между ребенком и родителями, сиблингами и врачами является онкопсихолог. В этой связи роль психологической работы чрезвычайно высока. Психолог, с одной стороны, может выступить в качестве медиатора между пациентом и его близкими, а с другой – помочь больному в снятии эмоционального напряжения как с помощью непосредственной работы с переживаниями, так и путем формирования эмоционально-коммуникативных навыков.

Правильное сообщение диагноза, учитывая возрастные особенности снижает уровень депрессии, негатив-

ных поведенческих изменений и приводит к наиболее хорошим психологическим состояниям даже в отдаленном будущем.

Понимание детей разных возрастов о болезнях можно описать ссылаясь на теорию Ж.Пиаже и на примерах из практики, во время работы с онкологическими пациентами в НЦПиДХ г.Алматы

Существуют определенные возрастные особенности, и по ним строится схема общения с детьми. Но необходимо быть очень внимательным к тому, что сам ребенок думает и понимает о своей болезни, какие вопросы интересуют его в первую очередь.

Сенсомоторная стадия (0-2 года). Дети в этой возрастной категории не способны различать между собственной личностью и внешним физическим миром, и зависимы от мнения родителей или опекуна. В этом возрасте преобладает чувство привязанности что бы ощущать безопасность и спокойствие. Дети ближе к 2 годам учатся связывать определенные события с окружающей средой и могут развивать условные рефлексы в качестве копинг-стратегий на стрессовые события, но по-прежнему зависимы от родителей или опекуна и требуют интерпретации своим переживаниям здесь и сейчас. Чтобы объяснить болезнь требуется развивать когнитивные схемы сознательного воспоминания о предыдущем опыте и развитие семантического или декларативного знания.

Пример 1: 2х летний мальчик стал беспокойным когда в палату зашла медсестра в белом халате, тогда как та же медсестра заходила в розовом халате ребенок никаких беспокойств не проявлял. Медсестра белый халат одевала в период химиотерапии а розовый халат носила на поддерживающей фазе лечения.

Предоперационная стадия (2-7 лет). Во время предоперационного периода дети начинают изъясняться с помощью языка. В этот период ребенок еще довольно эгоцентричен (не способен понять точку зрения других людей). Концепция эгоцентризма помогает нам понять, почему дети временами не желают делать то что им говорят. Понятие болезни на этом этапе включает феноменизм – то есть болезнь вызывается событиями или сенсорными стимулами. Болезненные процедуры на этом этапе воспринимаются ребенком как наказание за непослушание или за какое-либо неправильное действие.

Пример 2-4: 3х летний ребенок огорчился увидев медсестру с назогастральным зондом подумав что его медсестра ухаживает только за ним и устанавливать будут ему. А медсестра шла к другому ребенку.

У 6 летнего мальчика начались ожидаемые побочные эффекты от химиотерапии, на что сказал мальчик – «я думал от лечения самочувствие становится только лучше».

Конкретная операциональная стадия (7-11 лет). Во время конкретной операциональной стадии дети начинают осознавать понятия времени, пространства и числа. Дети на этом этапе понимают, что болезнь может быть вызвана контактом с болезнетворными микробами или переохлаждением. Так же дети в этом периоде считают что болезнь можно вылечить с помощью простых мер, таких как: постельный режим, прием препаратов только внутрь.

Пример 5. 7-летний мальчик у которого брат умер от диссеминации абдоминальной нейробластомы подумал что, он тоже заболел раком так как у него начал болеть желудок после того как гладил грязную собаку и часто обнимал брата.

Стадия формальных операции (после 11 лет). Мышление больше основывается на абстрактных принципах. На стадии формальных операции у ребенка формируются полноценные интеллектуальные способности взрослого. На этом этапе дети могут понять что может быть много взаимосвязанных причин которые могут приводить к болезни.

Пример 6-7. 12-летний мальчик сказал онкопсихологу при беседе что причиной его онкологического заболевания является ушиб колена, который он получил споткнувшись во время спортивной тренировки.

Кроме того, ребенок должен быть готов к тому, что не все люди, в том числе и взрослые, знают об онкологических заболеваниях столько, сколько знает он сам. И эти люди могут по-разному реагировать на него. Они могут говорить вещи, которые противоречат тому, что он слышал от родителей или врачей. Общение с такими людьми может породить у ребенка сомнения и страхи, а в результате и озлобление на то, что говорили ему родители. Если родители будут поощрять ребенка обсуждать с ними подобные разговоры, то можно откорректировать любые заблуждения, которые у него возникнут.

Важно помнить, что у ребенка сохраняются все эмоциональные потребности, характерные для его возраста.

Пребывая в постоянной стрессовой ситуации у родителей вырабатывается “шестое чувство” в отношении ребенка. И для них нет необходимости смотреть на проблемы через поведение ребенка, если проблемы и так очевидны. Но родителям и окружению можно посоветовать и дать понять, что врачам, медсестрам, психологу, возможно, уже приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, и, опираясь на профессиональные знания и опыт, они могут помочь вам - легче наладить доверительную взаимосвязь с детьми, с учетом их возрастных особенностей, которая так необходима во время длительного и нелегкого пути к выздоровлению.

Список литературы:

1. Schonfeld D.J., Quackenbush M. *After a loved one dies: How children grieve and how parent and other adults can support them.* - New York: New York life foundation, 2009.
2. Жан Пиаже. *Речь и мышление ребенка* - Париж: Румис. - 2008 ISBN 978-5-9650-0045-6.
3. Patenaude A.F., Kupst M.J. *Psychosocial functioning in pediatric cancer* // *Journal of Pediatric Psychology*. - 2005. - Vol.30. - P.9 – 27. Review.
4. Stam H., Grootenhuys M.A., Last B.F. *Social and emotional adjustment in young survivors of childhood cancer* // *Supportive care cancer*. - 2011. - N9. - P.489 – 513.
5. Абрамов Г. С. *Возрастная психология*. - М.: Академ Проект, 2000.
6. Рогов Е. И. *Общая психология (курс лекций)*. - М.: РИЦ Владос, 2000.

Тұжырым

М.М.Маратова, И.Р.Хусаинова, А.Д.Молдашбаева
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

**Қатерлі ісікке шалдыққан балаларға, жас
ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қолдау
көрсету**

Мақала онкологиялық аурулармен ауыратын балаларға психологиялық көмек берудің нақты мәселелеріне арналған. Психологиялық ауру баланың проблемаларын және жасына сәйкес оның қоршаған ортаны зерттеу нәтижелері келтірілген. Обыры бар балалары бар отбасыларға психологиялық қолдау мысалдары баяндалған.

Түйінді сөздер: педиатриялық онкология, онкопсихология, жас сипаттамалары, психологиялық қолдау.

Summary

Maratova M.M., Khussainova I.R., Moldashbayeva A.D.
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**Psychological support of children with cancer in
accordance with their age features**

The article is devoted to specific issues of psychological assistance to children suffering from oncological diseases. The results of the study of the psychological problems of the sick child and his environment are given with age-appropriate. Examples of psychological support of families with children with cancer are narrated.

Keywords: pediatric oncology, psychooncology, age characteristics, psychological support.